Латеральная аугментация с использованием нерассасывающейся титансодержащей мембраны из PTFE

Клинический случай

Использованный материал трансплантата: 50% аутогенной кости + 50% Ivory Graft

Применение: Латеральная аугментация перед установкой имплантата

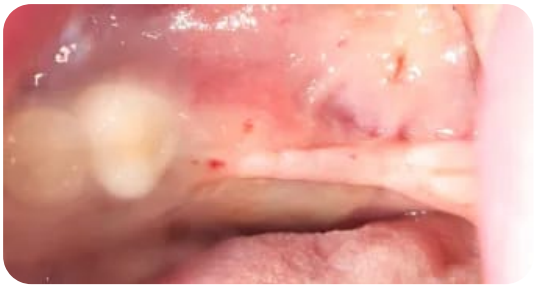
Проводил: д-р Ави Купершлаг



Перейти к содержанию

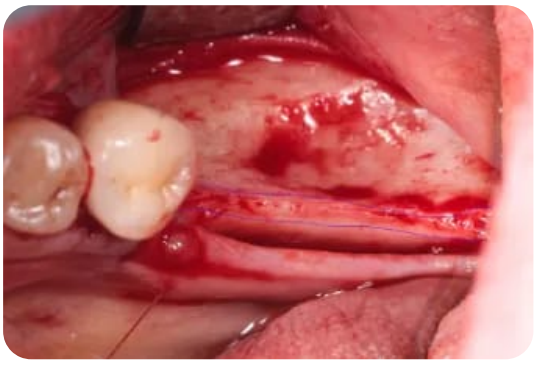
1 Предоперационное состояние

Клинический вид, демонстрирующий беззубый участок (область зуба 36). Наблюдается недостаточная ширина альвеолярного гребня для установки зубного имплантата, что указывает на необходимость латеральной аугментации кости.



2 Внутриоперационный этап

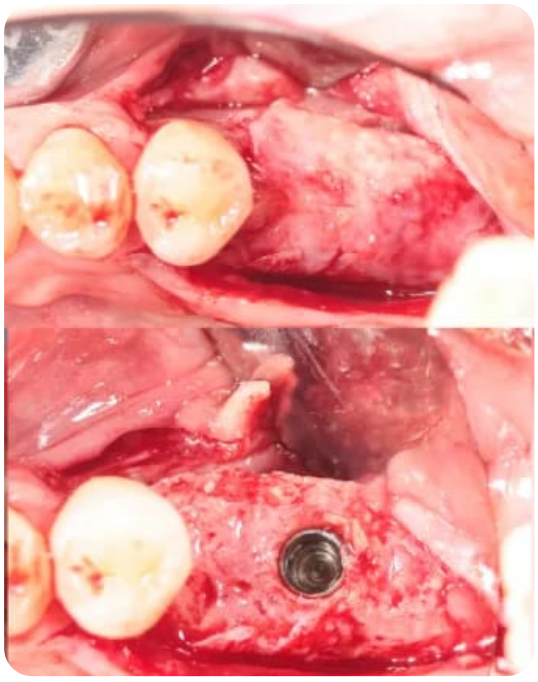
Отведение мукопериостального лоскута ясно демонстрирует значительный горизонтальный дефицит кости и обнажение альвеолярного гребня. Кровотечение из кости свидетельствует о хорошей васкуляризации, что является важным условием для успешной трансплантации.



Перейти к содержанию

3 Установка имплантата

Через четыре месяца после аугментации повторный осмотр хирургического участка показывает хорошую регенерацию кости, обеспечивающую достаточный объём для установки зубного имплантата. Введена формировочная втулка, и, судя по всему, достигнута хорошая первоначальная стабильность.



Перейти к содержанию

4 Сравнение до и после отведения лоскута

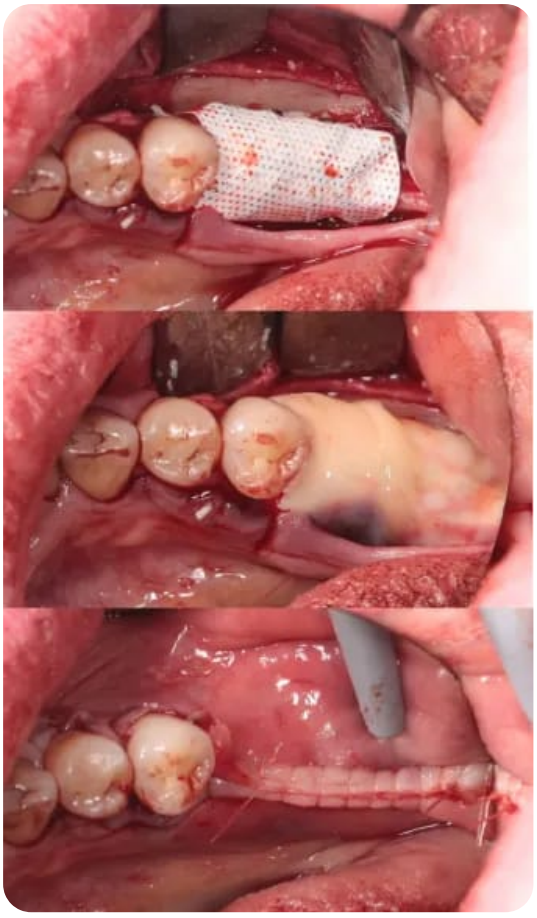
Внешний вид до операции и первоначальное обнажение костного дефекта после отведения лоскута. Очевиден значительный дефицит костной ткани, что оправдывает необходимость аугментации.



Перейти к содержанию

5 Установка мембраны и её покрытие

Титансодержащая PTFE мембрана установлена, полностью покрывая участок трансплантата. Две мембраны LPRF размещены для ускорения заживления и минимизации осложнений. Закрытие участка выполнено полностью с управлением лоскута без натяжения и надежным наложением швов.

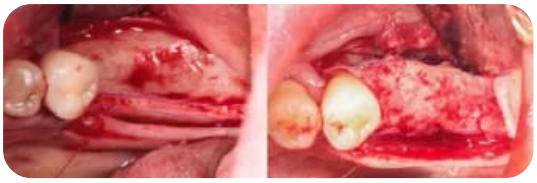


Перейти к содержанию

6

Прямое сравнение альвеолярного гребня до аугментации и сразу после установки трансплантата

Явно видна увеличенная толщина кости, демонстрирующая успешную латеральную аугментацию альвеолярного гребня с использованием трансплантата.



Результат случая:

Через четыре месяца при повторной операции отмечена регенерация кости в зоне трансплантата, достаточная для установки имплантата и последующей ортопедической реабилитации. Случай иллюстрирует применение аутогенной кости в сочетании с Ivory Dentin Graft™ под титансодержащей PTFE-мембраной и мембранами L-PRF при дефиците ширины альвеолярного гребня.